1.3.1. 수술의 정확한 수행

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	수술실위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 1.3 수술·시술의 정확한 수행 JCI Standard 7th Edition: IPSG.4, 4.1, ASC.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

제1조 (목적)

1. 수술 전 잘못된 확인과정, 비효과적인 의사소통, 환자참여 부족 등으로 발생할 수 있는 잘못된 수술, 수술부위, 다른 환자에 대한 수술 등을 예방하기 위한 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 수술부위 표시
   1) 수술부위 표시 대상
      (1) 좌·우 구분이 되어있는 부위
      (2) 다중구조(손가락, 발가락)
      (3) 다중levels(척추)
   2) 수술부위 표시 제외 대상
      (1) 단일구조
      (2) Mid-line orifices 부위(입, 항문, 요도 등)를 통한 수술
      (3) 개방상처
      (4) 심각한 응급 수술
   3) 수술부위 표시 방법
      (1) 수술실 입실 전 가능한 수술에 참여하는 의사가 수술부위 표시를 시행한다.
      (2) 수술부위 표시 시행 시 의식이 있는 환자(또는 보호자)를 참여시킨다. (의사소통이 불가능하거나 응급 수술로 표시가 어려운 경우 등은 제외 가능하다.)
      (3) 수술부위 표시는 즉각적으로 식별 가능한 '동그라미(O)'로 표시하며, 'X', 'NO' 등 모호한 다른 표식은 사용하지 않는다.
      (4) 수술부위 표시는 펜을 이용하며, 수술부위 절개 직전까지 수술부위 표시가 보여야 한다.
      (5) 신생아/미숙아, 치아 수술의 경우 신체 부위에 직접 표시하지 않고, 신체 이미지 등에 대신 표시하여 의료진 간 의사소통한다.
      (6) 환자가 거절하는 경우 필요성을 설명하고, 설명 후에도 거절하는 경우 내용을 기록하고 신체 이미지 등에 표시하여 의료진 간 의사소통한다.

(7) 척추수술, 복강경 수술 및 내시경수술, 손상된 피부, 응급수술, 유방수술, 성형수술, 신경외과 수술과 관련한 세부 수술부위 표시 방법은 수술 별 수술부위 표시지침 [부록1. 수술 별 수술부위 표시 지침]을 따른다.

2. 수술 전 확인

1) '수술 전 처치 및 간호상태 확인'을 통해 환자가 이동하는 단계별로 해당 내용을 확인한다.
2) 환자가 수술실에 도착하기 전까지 동의서를 확인한다.
3) 환자가 수술실에 도착하면, 환자이름, 예정 수술명, 수술 부위를 환자에게 말하도록 한다.
4) 소아 또는 환자 자신이 정보를 확인할 수 없는 환자(미성년자, 금치산자, 신경안정제를 투여한 상태, 언어장벽, 외상 또는 응급사고를 당한 경우 등 정확한 의사소통이 어려운 환자)는 보호자에게 확인한다.
5) 환자가 말한 내용(환자이름, 예정 수술명, 수술부위)을 의무기록, 동의서, 수술 스케줄 등을 이용하여 확인한다.
6) 수술 참여 의료진은 수술 관련 기록, 수술에 필요한 검사자료가 해당 환자의 것인지 이름과 등록번호로 확인한다.
7) 수술에 필요한 혈액제제, 특수장비, 임플란트가 있는 경우 모두 준비되었는지 확인한다.

3. 마취유도 전 확인(Sign In)

1) 환자 참여 하에 환자에게 이름, 예정 수술명, 수술부위를 말하도록 한다.
2) 소아 또는 환자 자신이 정보를 확인할 수 없는 환자(미성년자, 금치산자, 신경안정제를 투여한 상태, 언어장벽, 외상, 응급사고를 당한 경우 등 정확한 의사소통이 어려운 환자)는 수술실 입실 전 보호자에게 확인한 정보 등을 바탕으로 의료진이 함께 확인한다.
3) 환자가 말한 내용(환자이름, 예정 수술명, 수술부위)과 수술부위 표식이 일치하는지 의무기록, 동의서, 수술 스케줄 등을 이용하여 확인한다.
4) 환자 정보에 따른 마취 물품, 장비, 약물 준비 등을 확인한다.

4. 수술 시작 직전 또는 피부 절개 전 확인(Time Out)

1) 수행장소: 수술이 이루어지는 장소
2) 수행자: 수술 시작 시 참여하는 모든 수술 팀원(의사, 간호사 등)이 수행
3) 수행시기: 수술 시작 직전 또는 피부 절개 전 수행(환자가 의식이 있는 상태에서 진행하는 경우, 가능한 환자를 참여시킨다.)
4) 확인내용
   (1) 정확한 환자 확인(환자이름 및 등록번호)
   (2) 정확한 수술명
   (3) 정확한 수술 부위(좌/우, 다중구조, 다중수준 포함)
   (4) 사용 예정 특수 장비
   (5) 사용 예정 삽입물
5) 협진 수술로 인해 수술팀이 바뀔 때에는 'Time Out'을 다시 수행한다.
6) 'Time Out' 시행 내용 및 참여자 전원의 이름을 기록한다.

7) ‘Time Out’은 응급수술 등과 같이 생략했을 때보다 실시함으로써 환자에게 초래되는 위험이 더 클 경우는 제외한다.

5. 수술실 퇴실 전 확인(Sign Out)
   1) 환자의 수술실 퇴실 전 수술이 진행되는 장소에서 수술 팀원의 참여 하에 ‘Sign Out’을 시행한다.
   2) 확인 내용
      (1) 정확한 환자 확인(환자이름 및 등록번호)
      (2) 시행 수술명
      (3) (해당되는 경우) 기구, 거즈류, 바늘류의 계수 및 완전성
      (4) (검체가 있는 경우) 환자정보가 포함된 검체라벨을 부착한 검체의 개수 및 검체명
      (5) (해당되는 경우) 수술 중 발생한 장비 문제

제4조 (부록)
1. 수술 별 수술부위 표시 지침

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)